

Assunto: Solicitação de dados anonimizados sobre requerimentos de benefício por incapacidade temporária, perícia médica federal e análise documental/Attestmed

Solicito, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, acesso a base de dados tabular, anonimizada ou pseudonimizada, referente aos requerimentos de benefício por incapacidade temporária registrados nos sistemas do INSS, da Perícia Médica Federal, do Ministério da Previdência Social e/ou da DATAPREV, desde o primeiro registro informatizado disponível até 31/12/2025.

O pedido tem finalidade acadêmica, vinculado a pesquisa de mestrado acadêmico em Políticas Públicas e Governo da Fundação Getulio Vargas – FGV, cujo objeto é analisar a mudança de paradigma da Perícia Médica Federal, especialmente a transição de um modelo centrado na perícia presencial para modelos de triagem de risco, análise documental estruturada, parametrização estatística e potencial automação decisória em benefícios por incapacidade temporária.

A pesquisa busca construir arcabouço teórico e empírico para avaliação de modelos de triagem de risco em benefícios por incapacidade temporária, com possível evolução futura para sistema de classificação automatizada de requerimentos em grupos de baixa, média e alta complexidade decisória, tais como: deferimento documental parametrizado, solicitação de complementação documental ou encaminhamento para perícia médica presencial.

Ressalto que não solicito nome, CPF, NIT/PIS/PASEP, número de benefício identificável, endereço, telefone, e-mail, cópia de atestados, laudos, exames, prontuários ou qualquer outro identificador pessoal direto. Solicito, preferencialmente, microdados anonimizados ou pseudonimizados, com variáveis estruturadas, em formato adequado à pesquisa acadêmica e à análise estatística.

Solicito, preferencialmente, que os microdados anonimizados ou pseudonimizados sejam fornecidos em formato SQL, mediante uma das seguintes formas, em ordem de preferência:

1. banco SQLite anonimizado, em arquivo .sqlite, .sqlite3 ou .db;
2. arquivo SQL contendo estrutura e carga de dados, com instruções CREATE TABLE e INSERT INTO;
3. dump SQL em padrão compatível com banco relacional, preferencialmente PostgreSQL ou SQL padrão;
4. arquivo Parquet;
5. arquivos CSV relacionais;
6. arquivo XLSX, apenas caso os formatos anteriores não sejam tecnicamente viáveis.

Ressalto que não solicito acesso direto a banco de dados operacional, credenciais, ambiente de produção, tabelas internas identificáveis, conexão remota ou qualquer acesso aos sistemas do INSS, do Ministério da Previdência Social ou da DATAPREV. Solicito apenas uma extração estática, anonimizada ou pseudonimizada, correspondente ao recorte da pesquisa.

Caso a informação esteja organizada em mais de uma entidade lógica, solicito que a extração preserve, sempre que possível, a estrutura relacional da base, por exemplo:

1. tabela de requerimentos;
2. tabela de decisões administrativas;
3. tabela de modalidade de análise;
4. tabela de informações clínicas estruturadas;
5. tabela de documentos médicos;
6. tabela de histórico previdenciário/pericial agregado;

7. tabela de motivos de indeferimento, exigência documental ou encaminhamento à perícia presencial;
8. tabelas auxiliares de códigos, domínios e categorias.

Caso a base seja fornecida em SQL ou SQLite, solicito que sejam incluídos:

1. script de criação das tabelas, quando aplicável;
2. chaves primárias artificiais, aleatórias ou não identificantes;
3. chaves estrangeiras, quando houver relacionamento entre tabelas;
4. descrição das relações entre as tabelas;
5. tipos de dados de cada coluna;
6. índices eventualmente necessários para leitura analítica da base;
7. instruções mínimas para importação local da base em ambiente de pesquisa;
8. dicionário de dados com descrição das variáveis, códigos e categorias.

A unidade de análise solicitada é o requerimento de benefício por incapacidade temporária.

Solicito que a base contenha, se disponíveis, as seguintes variáveis ou equivalentes:

1. Identificação não nominal

- identificador aleatório do requerimento;
- identificador pseudonimizado do segurado, apenas se possível e sem reversibilidade, para permitir análise de recorrência;
- indicação se o requerimento é inicial, novo requerimento, prorrogação, recurso ou revisão.

2. Informações temporais

- data ou mês/ano da Data de Entrada do Requerimento;
- data ou mês/ano da decisão administrativa;
- data de emissão do documento médico;
- data de início do afastamento/repouso;
- quantidade de dias de afastamento solicitada pelo médico assistente;
- quantidade de dias de afastamento concedida, quando houver;
- tempo decorrido entre requerimento e decisão;
- tempo decorrido entre emissão do documento médico e decisão.

3. Informações territoriais e administrativas

- UF do requerente ou da unidade de análise;
- macroregião;
- Coordenação Regional de Perícia Médica Federal – CRPMF, se disponível;
- Divisão Regional de Perícia Médica Federal – DRPMF, se disponível;
- Gerência-Executiva, Superintendência Regional ou unidade administrativa equivalente, se disponível em nível não identificante.

4. Perfil não identificador do requerente

- idade ou faixa etária na data do requerimento;
- sexo/gênero registrado;
- categoria de segurado, se disponível;
- vínculo ou forma de filiação ao RGPS, em nível agregado;

- ocupação/CBO ou ramo de atividade/CNAE, se disponível em nível agregado.

5. Informações do benefício

- espécie do benefício;
- natureza previdenciária ou acidentária;
- indicação de benefício por incapacidade temporária comum ou acidentário;
- existência de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, quando aplicável e disponível em variável estruturada.

6. Modalidade de análise

- perícia médica presencial;
- análise documental/Atestmed;
- conversão de perícia presencial para análise documental;
- encaminhamento da análise documental para perícia presencial;
- perícia domiciliar/hospitalar, se disponível;
- decisão administrativa sem análise pericial presencial.

7. Resultado do requerimento

- deferido;
- indeferido;
- exigência documental;
- encaminhado para perícia presencial;
- cancelado;
- desistência;
- recurso apresentado;
- recurso provido ou improvido, quando houver.

8. Informações clínicas estruturadas

- CID-10 informado, preferencialmente em agrupamento de três caracteres;
- capítulo da CID-10;
- indicador de ausência de CID;
- indicador de diagnóstico textual sem CID;
- indicador de CID inválido, inconsistente ou não reconhecido, se houver;
- em caso de risco de reidentificação, solicito que CIDs raros sejam agregados por capítulo ou suprimidos conforme critério técnico do órgão.

9. Informações estruturadas sobre o documento médico

- presença de data de emissão;
- presença de assinatura;
- presença de identificação do profissional emitente;
- presença de registro em conselho profissional;
- presença de CID ou diagnóstico;
- presença de data de início do afastamento;
- presença de prazo estimado de repouso;
- indicação de documento ilegível;
- indicação de rasura;
- indicação de anexação de exames complementares, caso exista variável estruturada;

- motivo de não conformidade documental, quando houver.

10. Informações não identificantes do profissional emitente

- UF do conselho profissional;
- tipo de conselho profissional, quando aplicável;
- especialidade médica ou área profissional, se disponível;
- identificador pseudonimizado ou hash não reversível do profissional emitente, apenas se possível e juridicamente adequado, para análise estatística de padrões de emissão, sem identificação nominal.

11. Histórico previdenciário e pericial, em variáveis agregadas

- quantidade de benefícios por incapacidade anteriores;
- quantidade de requerimentos por incapacidade nos últimos 12, 24 e 36 meses;
- existência de benefício anterior pelo mesmo agrupamento CID;
- existência de perícia presencial anterior;
- resultado da perícia anterior, em categoria agregada;
- tempo desde a última perícia, se disponível;
- quantidade de indeferimentos anteriores por incapacidade, se disponível.

12. Motivos administrativos

- motivo de indeferimento;
- motivo de exigência documental;
- motivo de encaminhamento para perícia presencial;
- motivo de não conformidade documental;
- código ou descrição padronizada da conclusão administrativa/pericial, se houver.

Solicito, ainda, o fornecimento do dicionário de dados da base, contendo:

- nome técnico das variáveis;
- descrição das variáveis;
- tipo de dado;
- códigos e categorias possíveis;
- sistemas de origem;
- data inicial de disponibilidade histórica dos registros;
- eventuais mudanças de leiaute ou regra de negócio ao longo do período;
- descrição das tabelas, caso a base seja fornecida em formato relacional;
- relacionamento entre tabelas, quando houver;
- critérios de anonimização, pseudonimização, agregação ou supressão aplicados.

Caso não seja possível fornecer os microdados anonimizados ou pseudonimizados em SQL, SQLite, Parquet, CSV ou formato equivalente, solicito, subsidiariamente, o fornecimento das mesmas informações em tabelas agregadas, por:

- ano/mês;
- UF;
- macroregião;
- CRPMF;
- DRPMF;
- faixa etária;
- sexo/gênero;

- espécie de benefício;
- natureza previdenciária ou acidentária;
- modalidade de análise;
- capítulo CID-10 ou agrupamento CID-3;
- resultado do requerimento;
- faixas de dias solicitados;
- faixas de dias concedidos;
- motivo de indeferimento;
- motivo de exigência documental;
- motivo de encaminhamento à perícia presencial.

Caso a extração integral desde o primeiro registro disponível até 31/12/2025 seja considerada excessivamente onerosa, solicito que o órgão informe:

1. a data inicial de disponibilidade dos registros;
2. quais variáveis estão disponíveis;
3. qual recorte temporal é tecnicamente extraível;
4. qual unidade administrativa detém a governança da base;
5. se a guarda técnica dos dados é realizada pela DATAPREV;
6. qual seria o formato viável de extração parcial, anonimizada, pseudonimizada ou agregada;
7. se há leiaute, dicionário de dados ou documentação técnica das bases de requerimentos, perícias presenciais e análises documentais/Atestmed.

Caso os dados estejam sob guarda, gestão ou competência de outro órgão ou entidade, solicito o encaminhamento interno ao órgão competente ou a indicação expressa da unidade responsável pela base de dados.

Reforço que a solicitação busca exclusivamente dados estruturados, anonimizados, pseudonimizados ou agregados, para fins de pesquisa acadêmica em política pública, avaliação de desenho institucional, triagem de risco e modernização administrativa, sem identificação de segurados, profissionais emitentes, médicos assistentes ou servidores públicos.

Ass.: Gustavo Magalhães Mendes de Tarso.